

21. 급성복통

● 중요 포인트

1. 응급수술이 필요한 환자 감별
2. 원인에 따라 진단 및 치료 계획을 설명할 수 있는지

● Overview

1. **문진:** 통증을 호소하는 부위에 따라 우선적으로 감별해야 하지만, 소화기 질환 뿐만 아니라 반드시 비요생식계 질환과 여성의 경우 산과적 질환도 감별 필요
2. **신체진찰:** 신체검진은 복부 진찰 위주로 시행 + CVAT/DRE/골반내진 + 특이검사 Rovsing, Murphy, Psoas, Obturator
 - DRE 있을시 시간분배
 - 5 분 30 초: 문진
 - 2 분: 복부 시정타촉
 - 1 분 30 초 : DRE
 - 2 분 : 교육
3. **환자교육:** 응급질환 무엇인지 명확히 숙지, 수술이 필요할 경우 필요성 및 예후에 대해 설명, 문진 도중 심하게 호소하며 진통제 요구할 경우 충분히 배려하는 모습을 보이며 진료 수행 "많이 힘드시죠. 환자분 상태 파악에 꼭 필요한 것만 확인 후 최대한 빨리 약 드리겠습니다."
4. **감별진단:**

		의심질환	동반증상
상복부	위	위염 위궤양 십이지장궤양	명치 통증, 오심/구토, 흑색변(출혈 시), 식사 시 통증 변화(식후 - 위, 공복 - 십이지장)
		소화성 궤양 천공* 응급	소화성 궤양 증상 갑자기 발생한 칼로 찌르는 듯한 극심한 통증, 판자처럼 딱딱한 복부 두근거림/어지러움 Td/RTd +/-
	간담체	급성 췌장염	복부-명치 사이 찌르는 듯한 통증, 등 뒤로 뚫고 나가는 듯한 방사통 , 구부리거나/숙이면 완화 , 식사 후 악화 오심/구토
		급성 담낭염 담석증 담관염	RUQ Td + Murphy + 지방식 후 악화 오심/구토, 황달, 발열
		급성 간염	전신 쇠약/피로/근육통, 황달/짙은 소변 , 복수 , 간비대(오른쪽 윗배에 만져지는 덩어리)
	대동맥	복부 대동맥류 파열	찢어지는 듯한 통증, 등으로 뻗치는 통증 저혈압/호흡곤란/두근거림/어지러움 박동성 종괴
하복부	대장 (DRE 필요)	급성 충수돌기염* 응급	명치에서 RLQ 이동하는 통증 오심/구토, 식욕저하 Rovsing/Obturator/Psoas +/-/+
		염증성 장질환(IBD)	혈변, 만성 설사, 발열, 점막 궤양, 체중 감소
		계실염/결주머니염	RLQ/LLQ 통증 발열 Td/RTd +/- (localized RTd - localized peritonitis, General RTd - Panperitonitis)
		허혈성 대장염	고령, 고혈압/당뇨/부정맥 HTx + LLQ 통증, 쥐어짜는 듯한 통증 혈변/설사, 오심/구토, 복부팽만, 발열 Td +
		장간막 허혈	둔하고 쥐어짜는 듯한 통증 오심/구토, 소화불량 만성일 경우 식후 복통, 체중감소 가능
		장간막동맥 폐색	배꼽 주위 통증, 쥐어짜는 듯한 통증 복부강직, Td/RTd +/-

			오심/구토, 설사/혈변, 복부팽만
		장 폐색	배꼽 주위 통증, 쥐어짜는 듯한 통증 오심/구토, 방귀/대변 없음, 장음 항진 또는 소실, 복부팽만 개복 수술력 +
	비뇨 (CVAT 필요)	요관 결석	옆구리 통증, 간헐적 CVAT + 배뇨통, 혈뇨
		급성 신우신염	옆구리 통증 발열, 혈뇨 CVAT +
		방광염	치골 상부 Td 여성 빈뇨, 요절박, 배뇨통, 잔뇨
	여성 (골반진찰 필요)	자궁외임신*음급	젊은 여성, 무월경/생리 주기 변화, 임신 가능성
		난소꼬임*음급	젊은 여성 악화/완화 반복하는 극심한 아랫배 통증
		골반염증	발열, 질분비물 산부인과 수술력 +

1. 급성복통 * 기본: 복부 시형타촉, DRE

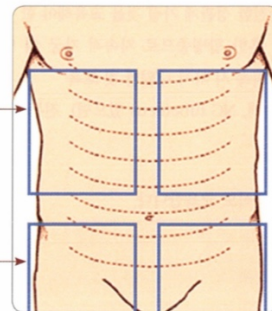


우상복부 통증

- 간, 담도계 질환
- 췌장염
- 폐렴

우하복부 통증

- 충수돌기염
- 장폐색
- 계실염
- 자궁 외 임신
- 난소, 나팔관 질환
- 자궁내막증
- 요로 결석



좌상복부 통증

- 위염, 위궤양
- 췌장염
- 비장 질환
- 심근경색, 폐렴

좌하복부 통증

- 계실염
- 장폐색(대장)
- 자궁 외 임신
- 난소, 나팔관 질환
- 자궁내막증
- 요로 결석

● 평가 목표

평가목표		
1) 응급수술이 필요한 환자 감별 2) 원인에 따라 진단 및 치료 계획 설명		
응급수술 필요한 환자 감별		원인: - 장 천공, 급성 충수염, 급성 담낭염, 장 폐색, 혈관 파열 응급 수술 필요 설명: - 지금부터 금식 유지. 정확한 진단 위해 영상 검사 신속히 진행 후 응급 수술 진행.
구체적인 성과		
병력 청취	복통의 양상 평가	기간: 위치: - RUQ: 담낭염, 담관염, 췌장염, 간염, 패렴/농흉, 흉막염, 횡격막 하 농양, Budd-Chiari synd - Epigastric: 식도염, 역류성 식도염, 위염, 위/십이지장 궤양, 췌장염, 심근경색, 심막염, 대동맥류 파열 - LUQ: 비장염/농양/허혈/파열 , 위염, 위궤양, 췌장염, 횡격막 하 농양 - RLQ: 충수돌기염, 막창자염, 결주머니염, 염증성장질환, 산부인과질환(난관염, 자궁외임신, 골반염), 비뇨기과질환(신우신염, 요로결석) - Periumbilical: 초기 충수돌기염, 위장관염, 장 폐색, 대동맥류 파열, 장간막동맥 폐색 - LLQ: 결주머니염, 염증성장질환, 과민대장증후군, 허혈성 대장염, 산부인과질환(난관염, 자궁외임신, 골반염), 비뇨기과질환(신우신염, 요로결석) - Whole: 기능성 복통, 위장관염, 장 폐색, 장간막 허혈, 과민대장증후군, 당뇨병성 위 마비, 복막염, 말라리아
		양상: - 급작스러운 통증 > 장천공, 혈관 파열, 요로결석 - 급격히 악화되는 통증 > 급성 췌장염, 장폐색, 담관염 - 점진적으로 악화되는 통증 > 급성 충수염, 게실염, 골반염 - 쥐어짜는 듯한 통증 > 장폐색, 요로결석, 담석증 - 칼로 찌르거나 찢어지는 듯한 통증 > (장천공에 의한)복막염, 대동맥 박리 - 타는 듯한 통증 > 역류성 식도염, 위 궤양 - 은근한 명치 통증 > 소화성 궤양 - 명치 □ RLQ > 급성 충수염 - 우측 어깨 방사통 > 담낭염, 담석증 - 등 뒤 방사통 > 췌장염, 대동맥 박리 - 서혜부/생식기 방사통 > 요로결석
		정도: - NRS: 0-10 - QoL: 일상생활 지장 정도
	응급 수술이 필요한 상황을 시사하는 증상 또는 징후 확인	Red flag signs: - 저혈압, 빈맥 - 고열, 오한 - 의식 변화 - 복막자극징후 : RTd +, 불수의적 방어, 복벽 강직, 타진통 - 장음 청진 변화 - 박동성 종괴 - 갑작스러운 발생 - 통증의 강도가 시간이 지나도 줄지 않음 - 고령에서의 첫 급성 복통 - 항암 치료 중이거나 면역 억제 상태 - 무월경 - 과거 복부 수술력 + 방귀 안나옴 - 혈변/흑색변

		의심질환	동반증상	위험요인
원인에 따른 동반 증상과 위험요인 평가	위	위염 위궤양 십이지장궤양	명치 통증, 오심/구토, 흑색변(출혈 시), 식사 시 통증 변화(식후 - 위, 공복 - 십이지장)	NSAIDs(진통제) 장기 복용, H. pylori 감염, 흡연, 음주
		소화성 궤양 천공* 응급	소화성 궤양 증상 갑자기 발생한 칼로 찌르는 듯한 극심한 통증, 판자처럼 딱딱한 복부 두근거림/어지러움 Td/RTd +/+	NSAIDs(진통제) 장기 복용, H. pylori 감염, 흡연, 음주, 과거 궤양 병력
	간담체	급성 췌장염	복부-명치 사이 찌르는 듯한 통증, 등 뒤로 뚫고 나가는 듯한 방사통, 구부리거나/숙이면 완화, 식사 후 악화 오심/구토	만성적인 음주, 흡연, 담석, 고중성지방혈증
		급성 담낭염 담석증 담관염	RUQ Td + Murphy + 지방식 후 악화 오심/구토, 황달, 발열	4F (Female, Fat, Forty, Fertile), 급격한 체중 감량, 고지방 식이
		급성 간염	전신 쇠약/피로/근육통, 황달/짙은 소변, 복수, 간비대(오른쪽 윗배에 만져지는 덩어리)	짙은 음주
	대동맥	복부 대동맥류 파열	찢어지는 듯한 통증, 등으로 뻗치는 통증 저혈압/호흡곤란/두근거 림/어지러움 박동성 종괴	흡연, 고혈압, 남성, 고령
	대장 (DRE 필요)	급성 충수돌기염* 응급	명치에서 RLQ 이동하는 통증 오심/구토, 식욕저하 Rovsing/Obturator/Psoas +/+/+	젊은 연령층
		염증성 장질환(IBD)	혈변, 만성 설사, 발열, 점막 궤양, 체중 감소	젊은 연령층, 서구화된 식단, 가족력
		계실염/결주머니염	RLQ/LLQ 통증 발열 Td/RTd +/+ (localized RTd – localized peritonitis, General RTd – Panperitonitis)	고령, 저섬유질 식이, 비만, 흡연, 변비
		허혈성 대장염	고령, 고혈압/당뇨/부정맥 HTx + LLQ 통증, 쥐어짜는 듯한 통증 혈변/설사, 오심/구토, 복부팽만, 발열 Td +	심혈관계 질환, 변비, 고령, 탈수
		장간막 허혈	둔하고 쥐어짜는 듯한 통증 오심/구토, 소화불량	심혈관계 질환

				만성일 경우 식후 복통, 체중감소 가능	
			장간막 동맥 폐색	배꼽 주위 통증, 쥐어짜는 듯한 통증 복부강직, Td/RTd +/- 오심/구토, 설사/혈변, 복부팽만	심혈관계 질환, 심방세동, 심장 판막 질환
			장 폐색	배꼽 주위 통증, 쥐어짜는 듯한 통증 오심/구토, 방귀/대변 없음, 장음 항진 또는 소실, 복부팽만 개복 수술력 +	과거 개복 수술력, 대장암, 탈장
		비뇨 (CVAT 필요)	요관 결석	옆구리 통증, 간헐적 CVAT + 배뇨통, 혈뇨	탈수, 가족력, 단백질/나트륨 과다 섭취
			급성 신우신염	옆구리 통증 발열, 혈뇨 CVAT +	당뇨, 요로 기형, 여성, 최근 방광염 병력
			방광염	치골 상부 Td 여성 빈뇨, 요절박, 배뇨통, 잔뇨	여성, 성관계 후, 소변 참는 습관
		여성 (골반진찰 필요)	자궁외임신*응급	젊은 여성, 무월경/생리 주기 변화, 임신 가능성	골반염 병력, 자궁 내 장치, 흡연, 난관 수술력
			난소꼬임*응급	젊은 여성 악화/완화 반복하는 극심한 아랫배 통증	난소 낭종 또는 종양 병력
			골반염증	발열, 질분비물 산부인과 수술력 +	다수의 성 파트너, 최근의 산부인과 시술, 젊은 가임기 여성
	환자가 수치심을 느끼지 않도록 배려	복부 증상을 정확히 파악하기 위해서는 실례지만 배변 습관에 대해서도 몇 가지 여쭙 봐야 합니다. 진료를 위해 꼭 필요한 질문이니 편하게 말씀해 주셔도 됩니다. 이런 증상은 장 건강을 체크할 때 가장 먼저 확인하는 아주 일반적인 지표입니다.			
신체 진찰	응급수술이 필요한 상황인지 감별하기 위한 신체진찰	기본 신체 진찰	VS unstable: Hypotension, Tachycardia, Fever/Chill 의식 변화		
		복부 진찰	복막자극징후 : RTd +, 불수의적 방어, 복벽 강직, 타진통 장음 청진 변화, 복부 팽만 박동성 종괴		
	유발 원인을 감별하기 위한 복부진찰	기본 신체 진찰	VS 확인 눈(빈혈, 황달) 입(탈수), 목(림프절), 피부(탈수)		
		복부 진찰 특이 검사	시 - 청 - 타 - 촉 간비대, 비장비대, 복수 대장 병변 의심 > DRE 산부인과 질환 의심 > 골반 진찰 비뇨기과 질환 의심 > CVAT 충수돌기염 > McBurney/Psoas/Obturator/Rovsing 담낭염 > Murphy		
	환자가 수치심을 느끼지 않도록 배려	환자 수치스럽지 않게 (진찰 동의, 설명, 불필요한 곳 가려주기)			
진단 및 치료	원인에 따라 진단계획 수립	기본 검사	혈액검사	빈혈 소화 효소, 간 수치, 전해질	
			영상검사	X-Ray 식도, 위 > 위내시경	

				간담체 > 복부 USG, 복부 CT 대장 > 대장내시경
		특이 검사	위	요소날숨검사/신속요소분해검사, 24 시간 식도 pH 검사
			간	바이러스 항체검사
			대장	대변 잠혈 검사
			비뇨기과	소변검사
			산부인과	골반 USG
	응급조치가 필요한 환자 감별 /응급치료가 필요한 환자를 감별하고 치료 계획 수립	소화성 궤양 천공, 복부 대동맥류 파열 > 개복 수술 필요 급성 충수돌기염, 자궁외 임신, 난소꼬임 > 복강경 수술 필요		
		지금부터 금식 유지. 정확한 진단 위해 영상 검사 신속히 진행 후 응급 수술 진행 소화성 궤양 천공 > 흉부 X-Ray, 옆 누움 흉부 X-Ray 급성 충수돌기염 > 복부 USG 자궁 외 임신, 난소 꼬임 > 골반 USG		
	원인 질환의 치료 계획 수립	위염	양성자펌프억제제 + 제산제	
		위궤양	H.pylori 제균 치료(3 제 : 양성자펌프억제제+Amoxicillin+Clarithromycin	
		십이지장궤양	4 제 : 양성자펌프억제제+Bismuth+Metronidazole+Tetracycline)	
		소화성 궤양 천공*응급	응급 개복 수술	
		급성 췌장염	금식 유지, 췌장효소보충, 혈당 조절, 진통제, 코위관 삽입	
		급성 담낭염 담석증 담관염	ERCP 및 담낭 절제술, 항생제	
		급성 간염	항바이러스제, 보존적 치료(수액, 전해질 교정)	
		복부 대동맥류 파열	응급 수술	
		급성 충수돌기염*응급	충수돌기절제술	
		염증성 장질환(IBD)	항염증제 5-ASA, Budesonide	
		게실염/결주머니 염	항생제 Ciprofoxacin, 3G Cepha + Metronidazole	
		허혈성 대장염	원인 제거 + 보존적 치료(수액, 전해질 교정) 괴사 의심 > 수술	
		장간막 허혈	항혈소판제, HTN/DM/이상지질혈증 치료 심할 경우 endovascular stenting, surgical thrombectomy	
		장간막 동맥 폐색	혈전색전제거술, 이미 괴사한 장 수술적 제거 항응고제, 광범위 항생제	
		장 폐색	수액 공급, 비위관 삽입	
		요관 결석	수액치료. 진통제, USG 쇄석술	
		급성 신우신염	항생제 Ceftriaxone	
		방광염	항생제 Fosfomycin	
		자궁외임신*응급	MTX, VS unstable □ 응급 수술	
		난소꼬임*응급	꼬임 풀기 및 낭종 절제술	
		골반염증	항생제 Ceftriaxone	
환자 교육	응급수술이 필요한 환자에게 수술의 필요성 설명	생활습관 개선	식사 규칙적으로 먹기, 맵고 자극적인 음식 피하기, 야식 피하기 과일과 채소 등 지방은 적고 섬유질이 많은 음식 많이 먹기 금연 금주 커피/탄산음료 줄이기 음식 충분히 씹어 삼키기, 과식하지 않기 적절한 유산소 운동과 체중 조절 당뇨 조절 적당한 휴식/수면, 스트레스 관리	

			진통제 등 약물 사용 전 의사와 상담 (과민대장증후군에서 고식이섬유 식사 강조)
		추가적 검사 설명	음식 심키기 어려움/어지러움/객혈/혈변/흑색변 즉시 내원 필요 내시경을 할 경우 금식이 필요할 수 있음
	응급처치나 수술이 필요한 경우 환자의 불안감을 최소화 할 수 있도록 설명	급성 충수돌기염 > 수술을 받을 경우 대부분 후유증 없이 완치됨	

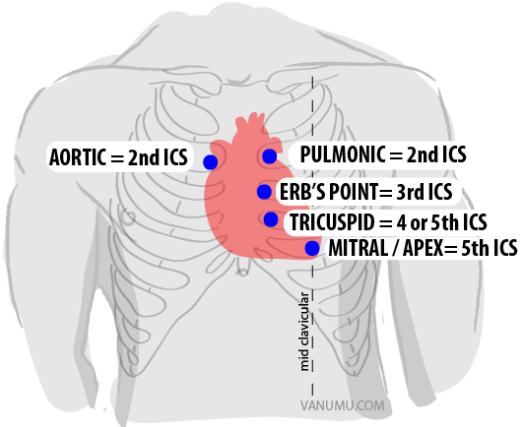
● 원인 질환 정리

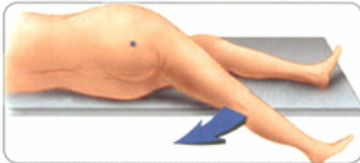
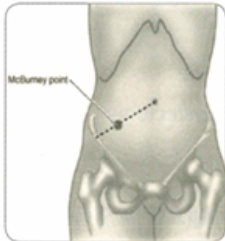
질환	질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료
위염 위궤양 십이지장 궤양	위 점막에 염증 궤양-혈어서 깊게 패임 십이지장: 위 바로 밑 장	명치 통증, 오심/구토, 흑색변(출혈 시), 식사 시 통증 변화(식후 - 위, 공복 - 십이지장)		위내시경 요소날숨검사/신속요 소분해검사, 24 시간 식도 pH 검사	양성자펌프억제제 + 제산제 H.pylori 제균 치료(3 제 : 양성자펌프억제제+Amoxicillin+Clarthr omycin 4 제 : 양성자펌프억제제+Bismuth+Metronida zole+Tetracycline)
소화성 궤양 천공* 응급	위나 장에 구멍남 음식물/공기 배안으로 새는중	소화성 궤양 증상 갑자기 발생한 칼로 찌르는 듯한 극심한 통증, 판자처럼 딱딱한 복부 두근거림/어지러움 Td/RTd +/-		흉부 X-Ray, 옆 누움 흉부 X-Ray, 복부 CT	응급 개복 수술
급성 췌장염	췌장=이자 갑작스러운 염증- >심한 복통	복부-명치 사이 찌르는 듯한 통증, 등 뒤로 뚫고 나가는 듯한 방사통, 구부리거나/숙이면 완화, 식사 후 악화 오심/구토		복부 CT	금식 유지, 췌장효소보충, 혈당 조절, 진통제, 코위관 삽입
급성 담낭염 담석증 담관염	담즙-간에서 만든 소화액 담낭-담아두는 주머니 담관-내려오는길, 돌김/염증	RUQ Td + Murphy + 지방식 후 악화 오심/구토, 황달, 발열		복부 USG, 복부 CT	ERCP 및 담낭 절제술, 항생제
급성 간염	간에 급성 염증	전신 쇠약/피로/근육통, 황달/짙은 소변, 복수, 간비대(오른쪽 윗배에 만져지는 덩어리)		복부 CT	항바이러스제, 보존적 치료(수액, 전해질 교정)
복부 대동맥류 파열	배 속 큰 혈관이 터짐	찢어지는 듯한 통증, 등으로 뻗치는 통증 저혈압/호흡곤란/두근거림/어지러움 박동성 종괴		복부 CT	응급 개복 수술
급성 충수돌기 염* 응급	충수(맹장)에 염증	명치에서 RLQ 이동하는 통증 오심/구토, 식욕저하 Rovsing/Obturator/Psoas +/-/+		복부 USG, 복부 CT	충수돌기절제술, 항생제
염증성 장질환(IBD)	면역 세포가 자신의 장 점막을 적으로 착각하고 계속 공격하여 염증을 일으키는 것	혈변, 만성 설사, 발열, 점막 궤양, 체중 감소		대장내시경, 대변 검사, 조직검사	항염증제 Budesonide, Steroid
게실염/결 주머니염	대장 벽 옆 주머니 같은 게실에서 염증 심해지면 구멍이 터질 수 있음	RLQ/LLQ 통증 발열 Td/RTd +/- (localized RTd – localized peritonitis, General RTd – Panperitonitis)		복부 CT *대장 내시경, 대장 조영술 금기	항생제 Ciprofloxacin, 3G Cepha + Metronidazole
허혈성 대장염	대장으로 가는 혈관 일시적으로 좁아짐 ▯ 피가 덜 가서 근육이 멎치고 아픈 것이랑 같은 개념	고령, 고혈압/당뇨/부정맥 HTx + LLQ 통증, 쥐어짜는 듯한 통증 혈변/설사, 오심/구토, 복부팽만, 발열 Td +		복부 CT, 대장내시경	원인 제거 + 보존적 치료(수액, 전해질 교정) 괴사 의심 > 수술
장간막 허혈	장 전체에 피를 공급하는 혈관에 문제가 생겨 혈류가 줄어들	둔하고 쥐어짜는 듯한 통증 오심/구토, 소화불량 만성일 경우 식후 복통, 체중감소 가능		복부 CT, 복부 Duplex USG, CT 혈관 조영술	항혈소판제, HTN/DM/이상지질혈증 치료 심할 경우 endovascular stenting, surgical thrombectomy
장간막	장으로 가는 가장 큰	배꼽 주위 통증, 쥐어짜는 듯한 통증		복부 CT, 복부	혈전색전제거술, 이미 괴사한 장 수술적

동맥 폐색	동맥에 피떡이 막음	복부강직, Td/RTd +/- 오심/구토, 설사/혈변, 복부팽만	Duplex USG, CT 혈관 조영술, ECG/심초음파	제거 항응고제, 광범위 항생제
장 폐색	장 막힘 □ 음식물, 가스 통과 X	배꼽 주위 통증, 쥐어짜는 듯한 통증 오심/구토, 방귀/대변 없음, 장음 항진 또는 소실, 복부팽만 개복 수술력 +	복부 CT	수액 공급, 비위관 삽입
요관 결석	소변 내려오는길 에 돌이 낀 (콩팥-> 방광)	옆구리 통증, 간헐적 CVAT + 배뇨통, 혈뇨	콩팥요관방광 단순촬영, 골반 CT, 소변검사	수액치료. 진통제, USG 쇄석술
급성 신우신염	신장에 세균 감염	옆구리 통증 발열, 혈뇨 CVAT +	복부 CT, 소변 배양 ra 사	항생제 Ceftriaxone/Ciprofloxacin
방광염	세균이 방광에 들어와 염증 발생	치골 상부 Td 여성 빈뇨, 요절박, 배뇨통, 잔뇨	소변 배양 검사	항생제 Fosfomycin
자궁외임 신*응급	임신이 자궁 밖에서	젊은 여성, 무월경/생리 주기 변화, 임신 가능성	골반 USG, 소변 임신 검사	MTX, VS unstable □ 응급 수술
난소꼬임*응 급	난소-난자 저장하고 배란 자궁 양옆 위치	젊은 여성 악화/완화 반복하는 극심한 아랫배 통증	골반 USG	꼬임 풀기 및 낭종 절제술
골반염증	골반 내 장기(자궁/난소) 세균	발열, 질분비물 산부인과 수술력 +	골반 USG	항생제 Ceftriaxone

● 대본

자기소개/환자확인/환자동의/활력징후	
“진료 대기 시간이 길었는데 오래 기다리시느라 고생 많으셨습니다./몸도 좋지 않은데 병원까지 오셔서 기다리시느라 고생이 많으셨습니다.” “복부 증상을 정확히 파악하기 위해서는 실례지만 배변 습관에 대해서도 몇 가지 여쭙 봐야 합니다. 진료를 위해 꼭 필요한 질문이니 편하게 말씀해 주시면 많은 도움이 될 것입니다.”	
O	언제부터 갑자기/서서히 하루 중 언제 상황
L	어디가 아픈지/“아픈데 손으로 짚어보세요.” 다른 곳으로 이동하는지/뻘치는지
D	지속/있다없다 얼마나 자주
Co	악화
Ex	이전에도? □ 치료, PPI(제산제)
C	개방형: “어떻게 아픈지 자세히 설명해주시겠어요?” 양상: 쥐어짜는듯/타는듯/베이듯/칼로 찌르는듯 얼마나 심한지: NRS, QoL □ “많이 힘드셨겠습니다.”
A	개방형: “다른 불편한 곳은 없으세요? 네. 그럼 제가 몇 가지 자세하게 확인해보겠습니다.”
	전신 F/C/Fatigue/WL/피로/부종
	소화기 식욕저하/구역/구토 “대변, 소변은 좀 어떠세요? 색/양/횟수/특이사항?” □ 변비(방귀?)/설사/토혈/혈변/흑색변/지방변 복부팽만/복부종괴/황달 □ 황달 있는 경우 가려움/복수/소변대변 색변화
	순환기/호흡기 가슴통증/호흡곤란/기침
	부인과 질출혈/질분비물 □ 양/색/냄새 변화
	비뇨기 배뇨통/소변색 변화/혈뇨/빈뇨
F	개방형: “증상이 어떨 때 좀 괜찮아지고/심해지나요?”
	식사 전 > 십이지장 궤양 후 > 위염, 위 궤양 음주 > 위염, 위 궤양, 췌장염 기름진 식사 > 담도계, 췌장염
	자세 앞으로 숙이면 완화 > 췌장염 누우면 악화 > 위식도역류질환
	배뇨/배변 배뇨/배변 등에 의해 통증 완화/악화?
E	건강검진, 위내시경/대장내시경 담석/요로결석 예방접종: 간염
요약 및 PPI	“지금까지 말씀하신 것을 요약하자면 ~.” “제가 질문을 많이 했는데 잘 대답해주셔서 감사합니다. 몇 가지만 더 여쭙도록 하겠습니다.”
외	수술/외상/입원
과	HTN/DM/고지혈증/결핵/간
약	약물/영양제/한약 소염진통제, 제산제, 항생제 > 궤양 고혈압 약 복용 제대로? ? 복부 대동맥류 파열
사	술/담배/커피/직업/스트레스 식습관: 규칙적/기름지고 자극적인 음식/최근 드신 음식 중 원인이 될 만한 것(해산물, 안 먹던 음식) 운동: 규칙적/일주일 횟수
가	소화기 암/질환
여	월경력: 마지막 생리 시작일 □ 기간/주기/규칙성/양/월경통 산과력: 임신가능성/피임(자궁내장치)/결혼/아이/출산(자분/제왕/출산시 출혈)/유산(수술/자연유산)/수유
요약 및 PPI	“네. 이로써 문진은 마치도록 하겠습니다.” “혹시 더 말씀해주시고 싶은 것 있으실까요? 편하게 말씀해주세요.”

환자동의	
“정확히 어디가 아픈지 확인하기 위해 신체진찰을 진행해야 합니다. 과정 중에 신체 노출과 접촉이 있을 수 있으나, 불편하시지 않게 필요한 부분만 노출하고 최대한 신속히 확인하겠습니다. 괜찮으실까요? 중간중간 불편하시면 언제든지 말씀해주세요.”	
기본 신체진찰	
VS 확인	
눈	빈혈/황달
입	탈수
목	림프절
피부	긴장도/오목부종/맥박
순환기/호흡기 의심 시 심장 청진 폐 청진 시행	
“윗배가 아프신 분들 중 사실은 가슴이 아픈데 배가 아픈 것 처럼 느낄 수 있습니다.”	
심음 청진	
호흡기 진찰	청진 맨 마지막 앉아서 후면만 진행 : 손 앞가슴 X 자, 살짝 앞으로 기대기
얼굴	부비동 압통 확인하기 비경 있으면 비경 콧구멍에 넣고 빛 비춰보기 맥박재라고 하고 호흡수 15 초 측정(16 회라고 뻗쳐) 청색증/근봉자 확인
사진	옷 올려보기 눈으로 보고 숨김게 쉬어보세요 : 가침도 해보세요 (앞뒤 다 확인)
촉진	등 뒤만 양 손등 대고 아 해보세요 4 번 엄지 모아지게 흉곽 감싸 안고 조이기 → 숨 쉬어보세요 : 흉곽 벌어짐/대칭
타진	ㄹ자로 8 군데 + 아래는 양 옆구리쪽으로 2 번 벌어지면서도 하가
청진	청진기 차가워요 + 데우기 ㄹ자로 듣기(8 번 + 아래옆구리 2 번)
복부 진찰	
“많이 긴장되시죠? 숨을 크게 들이마시고 편안하게 내뿜으시면 검사가 훨씬 수월해집니다. 잘하고 계십니다.” 많이 아파할 경우 □ “자세히 보고 정확히 진찰하려다보니 신체 검진 과정에서 불편을 드린 것 같습니다.”	
시	자세 누워서 무릎 굽힘, “명치부터 골반까지 노출하고 다른 부위는 가려드리겠습니다.” “아픈 곳 손으로 짚어보세요.” 외상/수술 흔적/팽만
청	“청진기 손으로 데우긴 하는데 차가울 수 있습니다. 불편하면 말씀해주세요.” 배 4 군데(3 초) + 명치
타	4 군데 이상, 아픈 곳 마지막으로 간: 세로로 Rt. Mid 쇄골 라인 따라 □ 유두부터 배꼽 아래까지 일직선 두드리기
	복수: 가로로 배 가운데 가로로 짚 두드리기 □ 왼쪽으로 벽보고 돌아서 누워 배 아래쪽 누워있는 부분 두드리기
촉	4 군데 이상 알개/깊게, 아픈 곳 마지막으로 압통 호소 □ 반동압통도 시행
	간: 왼손으로 받치고 오른손으로 아래에서 위쪽, 깊은 숨 쉬게하곤 촉진
	비장: 오른손으로 받치고 왼손으로 촉진
특이 검사	담낭/충수돌기염:

 [Psoas 징후] 오른쪽 허벅지를 펴(신전)할 때 통증이 있음 (충수돌기가 후복막에 위치한 경우) → 급성 충수돌기염  [Obturator 징후] 오른쪽 허벅지를 안쪽 돌림(내회전)시킬 때 통증이 있음(충수돌기가 골반쪽에 있을 때) → 급성 충수돌기염	 [Rovsing 징후] 왼쪽 아랫배를 촉진했을 때 오른쪽 아랫배에 통증이 발생 → 급성 충수돌기염  [McBurney 징후] 오른쪽 아랫배(ASIS와 배꼽의 중간)의 통증 → 급성 충수돌기염  [Murphy 징후] 오른쪽 윗배의 갈비뼈 아래 경계 부위를 가볍게 누른 상태에서 숨을 깊게 들이 마시면 갑자기 통증이 유발 → 급성 담낭염 비뇨: - CVAT (+)	
	DRE	
	안내	"항문괄약근과 직장 내 병변이 있는지 확인하는 검사입니다. 항문에 손가락 넣어서 만져보는 검사 불편하실 수 있지만 진단을 위해 필요한 과정입니다. 괜찮으실까요?"
	자세	등지고 누워+왼다리는 그냥 펴고+오른다리는 가슴에 붙도록 90도 구부리고 새우등 자세+엉덩이는 최대한 뒤로 빼서 새우등자세
	PPI	"옷 내려주시고, 불필요한 부분은 가려드리겠습니다. 안보여서 불안하겠지만 모든 과정 말로 설명하고 진행할테니 걱정 안하셔도 됩니다."
시진	항문 주변 덩이 셋길 궤양 염증 없음 변보듯 힘주기	
촉진	항문 주변 덩이/압통	
손가락	"손가락 넣겠습니다. 젤 차갑고 불편하세요." 2번 참을 때처럼 힘 주고 힘 빼기 "빼겠습니다. 끝났습니다. 고생 많으셨고 닦으실 수 있도록 여분 휴지 챙겨드리겠습니다."	
보고	변색성상+ 병변: 항문직장선 기준 *cm 상방+*cm 크기+*시 방향 동근모양+매끄러움/울퉁불퉁경계+고정/유동+압통	
마무리	"신체진찰 끝났습니다. 정리하시고 다시 돌아와주시면 됩니다. 협조해주셔서 감사합니다."	
골반진찰		
안내	"질 안쪽 손가락을 넣어서 자궁 및 부속기의 운동성/압통/종괴 유무 확인하는 검사입니다. 불편하실 수 있지만 진단을 위해 필요한 과정입니다. 괜찮으실까요?" 생리중/이전 성경험? 검사 이전 24시간 내: 질정/질세척/성관계/탐폰? 검사 이후 48시간 이후: 질정/질세척/성관계/탐폰?	
자세	옷 갈아입고 침대 누움 + 다리 M자 + 발은 발판 불필요한 부분은 가려드리겠습니다	
골반 내진	"외음부에 손이 닿을건데 너무 놀라지 마세요." 시진: "먼저 한번 보겠습니다. 발적/궤양 확인하겠습니다." "손가락을 질 안으로 넣겠습니다. 놀라지 마세요." "자궁경부 운동성/압통/종괴 확인하겠습니다." "누를 때 아픈가요?" "손가락 천천히 빼겠습니다. 놀라지마세요. 묻어 나온 질분비물 확인하겠습니다."	

진단검사		
기본 검사	혈액검사	빈혈 소화 효소, 간 수치, 전해질
	영상검사	X-Ray 식도, 위 > 위내시경 간담체 > 복부 USG, 복부 CT 대장 > 대장내시경
특이 검사	위	요소날숨검사/신속요소분해검사, 24 시간 식도 pH 검사
	간	바이러스 항체검사
	대장	대변 잠혈 검사
	비뇨기과	소변검사
	산부인과	골반 USG
	위염	양성자펌프억제제 + 제산제
	위궤양	H.pylori 제균 치료(3 제 : 양성자펌프억제제+Amoxicillin+Clarithromycin
	십이지장궤양	4 제 : 양성자펌프억제제+Bismuth+Metronidazole+Tetracycline)
	소화성 궤양*응급	응급 개복 수술
	급성 췌장염	금식 유지, 췌장효소보충, 혈당 조절, 진통제, 코위관 삽입
	급성 담낭염	
	담석증	ERCP 및 담낭 절제술, 항생제
	담관염	
	급성 간염	항바이러스제, 보존적 치료(수액, 전해질 교정)
	복부 대동맥류 파열	응급 수술
	급성 충수돌기염*응급	충수돌기절제술
	염증성 장질환(IBD)	항염증제 5-ASA, Budesonide
	게실염/결주머니염	항생제 Ciprofloxacin, 3G Cepha + Metronidazole
	허혈성 대장염	원인 제거 + 보존적 치료(수액, 전해질 교정) 괴사 의심 > 수술
	장간막 허혈	항혈소판제, HTN/DM/이상지질혈증 치료 심할 경우 endovascular stenting, surgical thrombectomy
	장간막 동맥 폐색	혈전색전제거술, 이미 괴사한 장 수술적 제거 항응고제, 광범위 항생제
	장 폐색	수액 공급, 비위관 삽입
	요관 결석	수액치료. 진통제, USG 쇄석술
	급성 신우신염	항생제 Ceftriaxone
	방광염	항생제 Fosfomycin
	자궁외임신*응급	MTX, VS unstable □ 응급 수술
	난소꼬임*응급	꼬임 풀기 및 낭종 절제술
	골반염증	항생제 Ceftriaxone
	생활습관 개선	생활습관 교정 (안심/회피,교정/검진접종/응급) 식사 규칙적으로 먹기, 맵고 자극적인 음식 피하기 금연 금주 커피줄이기 적절한 유산소 운동과 체중 조절 당뇨 조절 적당한 휴식/수면, 스트레스 관리
	추가적 검사 설명	음식 심키기 어려움/어지러움/객혈/혈변/흑색변 즉시 내원 필요 지금부터 금식 유지. 정확한 진단 위해 영상 검사 신속히 진행 후 응급 수술 진행 - 소화성 궤양 천공, 복부 대동맥류 파열 > 개복 수술 필요 - 급성 충수돌기염, 자궁외 임신, 난소꼬임 > 복강경 수술 필요 [국가암검진] 대장암은 만 50 세 이상 남녀 대상 매년 분변 잠혈검사를 시행 (이상 시 대장내시경 검사)

[도입] 갑자기 배가 아파서 많이 놀라셨을 것 같습니다.

[진단] 지금 ○○○님께 가장 의심되는 진단명은 '-'입니다. -는 ~한 질병입니다.

[감별] 하지만 다른 -이나, -이 있어도 이러한 증상이 나타날 수 있습니다.

[진단] 따라서 정확한 진단을 위해, 우선 기본적인 혈액검사로 소화효소, 간수치, 전해질, 빈혈 같은 전체적인 상태를 확인해볼 것이고, 영상검사로 위내시경/ USG/복부 CT/대장내시경을 시행해 확인해봐야 합니다. 내시경 검사를 진행할 경우 지금부터 금식을 하셔야 합니다.

[치료] -으로 진단될 경우 치료는 ~.

*소화성 궤양 천공, 복부 대동맥류 파열, 급성 충수돌기염, 자궁외 임신, 난소 꼬임일 경우 ▢ 지금부터 금식 유지하시면서 영상 검사 진행 후 바로 신속하게 응급 수술 진행할 예정입니다.

[교육] 배가 더 아프거나 다른 새로운 증상이 발생할 경우 언제든지 내원하세요. 그리고 생활 속에서 맵거나 자극적인 음식들은 피해주시고, 적절하게 운동을 해 주시고 금연과 금주를 해주신다면 증상 완화에 더 도움이 되실 것입니다

[질문] 궁금한 점이 있으시다면 편하게 물어보세요. 없으시다면, 이것으로 진료를 마치겠습니다. 수고 많으셨습니다.